

ABCDs 신체계측 파트3 - 혈압과 영양 (번역)

출처: AFMCP Chap4 ABCDs Anthropometrics Part3

1. 올바른 혈압 측정법

- 5분 조용히 앉기 (발 바닥 지지, 등 지지)
- 팔을 심장 높이에서 지지 — 흉곽 근육 사용 없이
- 가정 혈압이 진료실 혈압보다 더 정확
- 혈압약 시작 전 가정 혈압 모니터링 표준으로 권고

2. 혈압 목표치 (기관별)

- 일반 목표: 130-140/90mmHg (과거 120/80 목표에서 변화)
- 60세 이상 당뇨·신장질환 없을 시: 150/90까지 허용
- 당뇨·만성신장질환: <140/90 (내피세포 손상 더 심하므로)
- 2020 Cochrane 리뷰: 120/80 목표의 이점이 낙상·실신 위험을 상회하지 않음

3. 혈압 = 내피세포 기능의 지표

- 상승된 혈압 = 내피세포 기능 이상(Endothelial Dysfunction) 신호
- 내피세포 기능 이상 = 염증 증가 + 면역 이상 + 산화 스트레스
- "혈압을 낮춰야 한다"보다 "내피세포 기능 이상의 원인이 무엇인가?"를 먼저 질문
- 운동·수면·건강 체성분·영양소 교정 모두 혈압에 기여

4. 고혈압과 관련된 영양소 결핍

- 단백질: 적절한 단백질 섭취 → 내피세포 기능 지원
- 항염 지방(오메가-3): 혈관 염증 감소
- 식이섬유: 독소 결합·장내 미생물 균형
- 칼슘(Ca)·마그네슘(Mg)·칼륨(K)·아연(Zn): 혈관 이완·신경 조절
- 비타민 B6: 호모시스테인 조절 (항염)
- 비타민 C: 강력한 항산화, 내피세포 보호
- 비타민 D: 면역 조절, 레닌-안지오텐신 조절
- 콜린: 세포막 무결성, 신경 기능
- 파이토뉴트리언트(색깔 채소): 모든 항목이 혈압 개선 근거

5. Houston 연구 핵심 결과

- 고혈압 환자 대상 6개월 영양 + 운동 프로그램
- 미량영양소 결핍 교정 집중 시행
- 결과: 62%의 환자가 4-12개월 내 혈압약 중단 성공
- 혈압 120-126/80-84 달성 (영양 교정만으로)

6. ABCDs 신체계측 총괄 결론

- 신체계측은 심혈관/대사 위험 평가의 첫 단계
- 허리둘레·BRI: 내장지방을 저비용·간편하게 측정
- 체성분 분석: BMI 이상의 정보 제공

■ 상승된 혈압 = 영양소 결핍의 대리 지표